内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·炎症性肠病

（性感认识：UC 连续溃疡浅、CD 节段鹅卵石）浅溃疡:UC 细菌性痢疾

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

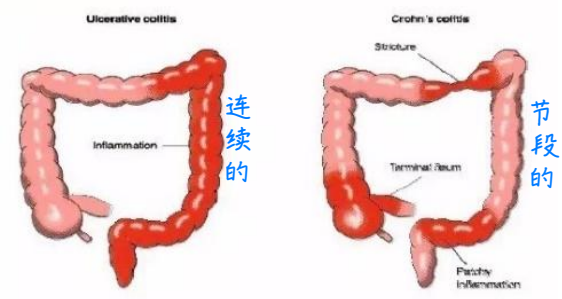
一、炎症性肠病（inflammatory bowel disease,IBD）概述

①环境因素作用于遗传易感者，在肠道微生物参与下、引起肠道**免疫失衡**，进而损伤肠黏膜屏障、导致肠黏膜持续的慢性炎症（炎症有终生复发倾向-慢性复发型）　抗免疫治疗,如糖皮质激素、免疫抑制剂

②炎症性肠病的主要类型有溃疡性结肠炎 UC 和克罗恩病 CD，它专指病因不明的一类肠道炎性疾病（不是微生物感染→抗生素多无效，但抗生素对某些炎症性肠病患者有益）炎症≠感染

肠道感染虽然不是病因,但对肠道疾病的发展有促进作用(菌群失调,诱发异常的免疫反应)→炎症性肠病容易加重/药物疗效变差

二、可能可能最可能



1.克罗恩病 CD

关注部位

（1）抗生素多无效，**右下**或脐周腹痛，可有**瘘管**（特征克瘘恩病）、腹腔脓肿、**肛周病变**　有些克罗恩病一开始就表现为肛周病变(肛裂、肛周脓肿)　本质:慢性穿孔

VS 肠结核:好发于回盲部

（2）**结肠镜（首选和金标准）**：好发于**回肠末端及邻近结肠，节段、跳跃性（病变间黏膜正常）**，**纵**行裂隙状深溃疡，**鹅卵石、铺路石样，非干酪肉芽肿**　VS 肠结核是横/环形溃疡,右下腹痛　VS 肠结核:钡灌肠跳跃征　VS UC是浅溃疡

复习肺结节病：活检支气管粘膜结节呈铺路石样、非干酪肉芽肿

VS 肺泡蛋白沉着症:影像学:磨玻璃影与正常组织截然分开呈地图样,铺路石样,蝴蝶样(肺门周围的肺泡渗出)

（3）CD 可累及全消化道，若发生在小肠：小肠镜、胶囊内镜、CT/MRI 肠道显像 CTE/MRE。CTE/MRE 还适合肛周脓肿术后不久的 CD　克罗恩最常见并发症就是肠梗阻,容易排不出来

CD合并肛周脓肿(很痛)不适合用内镜→用影像学检查CTE/MRE

2.溃疡性结肠炎 UC

（1）抗生素多无效，**左**下腹痛，多有**黏液脓血便**（离肛门近）、**里急后重**（累及直肠）　VS 肠结核、克罗恩病:黏液脓血便、里急后重少见

（2）黏液脓血便和腹泻是 UC 处于活动期的重要表现：

轻度	排便≤3 次/天、便血无或轻、脉搏＜90 次/分、体温＜37.8 度、Hb＞105g/L、血沉＜20mm/h
中度	介于轻度、重度之间
重度	**腹泻≥6** 次/天、便血明显、脉搏＞90 次/分、体温＞37.8 度、Hb＜105g/L、血沉＞30mm/h（10578369）

只达到了黏膜下层,一般溃疡达到了肌层

（3）**结肠镜（首选和金标准）**：好发于**直肠及乙状结肠，连续、弥漫性，浅**溃疡

复习细菌性痢疾：好发于直肠及乙状结肠，表浅不规则地图状溃疡